

Pancreatite aguda · Atlanta e conduta

Diagnóstico: dor típica + lipase/amilase $\geq 3\times$ + imagem se dúvida. Classifique leve/moderadamente grave/grave (Atlanta) e trate suporte, causa biliar e necrose infectada com critério.

Atlanta — ideia rápida

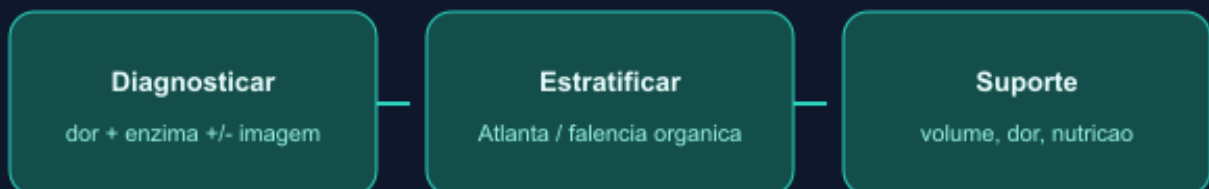
Dica - Atlanta — ideia rápida

Leve: sem falência orgânica nem complicação local. Moderadamente grave: falência transitória (<48 h) ou complicação local. Grave: falência persistente ≥ 48 h.

Fluxo: critérios diagnósticos !' gravidade/órgãos !' volume + nutrição + causa (cálculo/álcool).

Pancreatite aguda

Diagnosticar -> estratificar -> suporte



Conduta inicial

- Volume generoso com cristaloides e reavaliação hemodinâmica/diurese
- Analgesia; oxigenação; corrigir eletrólitos e glicemia
- Nutrição enteral precoce quando tolerar — evitar jejum prolongado 'por protocolo'
- USG de abdome para litíase; CPRE se colangite / obstrução biliar persistente

Imagem e infecção

Situação | Conduta

Diagnóstico claro, leve | TC precoce não obrigatória

Dúvida / gravidade / falha | TC com contraste (idealmente >72 h se necrose)

Necrose infectada | ATB + drenagem step-up; cirurgia tardia se preciso

Colecistolitíase etiológica | Colecistectomia na mesma internação se leve

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Antibiótico profilático de rotina na pancreatite estéril não está indicado. Reserve ATB para infecção documentada/suspeita forte (necrose infectada, colangite).

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

Pancreatite aguda: diagnosticar (2/3 critérios), estratificar gravidade (Atlanta/BISAP/Ranson) e suporte — ATB só se infecção documentada.

Atlanta guia prova: falência orgânica persistente "e48 h define grave.

Gravidade - Atlanta

Leve / moderada / grave

Leve

Sem falência orgânica
Sem complicação local
Suporte / alta precoce

Maioria dos casos

Moderada

Falência <48 h
Ou complicação local
Internar / observar

Necrose / líquido

Grave

Falência ≥48 h
UTI / suporte
Complicações frequentes

Alta mortalidade

BISAP "e3 associa-se a maior risco de gravidade/mortalidade — use junto com clínica e Atlanta.

BISAP (0-5)

Escore rápido a beira do leito

BUN > 25 mg/dL	1
Impaired mental status	1
SIRS (≥2 critérios)	1
Age > 60 anos	1
Pleural effusion	1

BUN>25 | Impaired mental | SIRS | Age>60 | Pleural effusion

Diagnóstico (2 de 3)

Lembre - Diagnóstico (2 de 3)

Dor típica epigástrica em faixa + lipase/amilase "e3× + achados de imagem. Imagem não é obrigatória se clínica + enzima fecham.

Ranson (conceito clássico)

Momento | Variáveis (ideia)

Admissão | Idade, leucócitos, glicose, LDH, AST

48 h | Queda Ht, !'BUN, Ca!“, PaO ,!“, déficit base, sequestro líquido

Leitura | Mais critérios = maior gravidade (corte clássico "e3)

Conduta inicial

- Volume agressivo precoce (cristaloides), analgesia, oxigenação
- Nutrição enteral precoce se tolerar; evitar jejum prolongado desnecessário
- Cálculo: USG; CPRE se colangite / obstrução biliar persistente
- ATB profilático de rotina: não; se necrose infectada !' ATB + drenagem/necrosectomia escalonada

Armadilha

Atencao - Armadilha

TC precoce demais pode subestimar necrose; use para dúvida diagnóstica ou deterioração — não 'só para completar' nas primeiras horas se já diagnosticado.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1